

Etablissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Crise convulsive prolongée – Midazolam buccal

Patient épileptique diagnostiqué : une dose buccale selon le plan nominatif, avec appel urgent selon les critères.

Indications

- Crise convulsive durant ≥ 5 min ou durée fixée par le plan individuel.
- Salves sans récupération chez un patient épileptique connu.
- Midazolam buccal nominatif, non périmé, avec prescription/protocole disponible.
- Hors enfant de 3 à < 6 mois en structure non hospitalière.

Vérifications préalables

- Noter l'heure de début ; chronométrer et appeler du renfort.
- Protéger sans contenir ; ne rien mettre dans la bouche.
- Vérifier identité, dosage, péremption et plan nominatif.
- Évaluer respiration, cyanose, traumatisme et récupération.

Recommandations / IMPORTANT

- Appel 15 : première crise, durée ≥ 5 min, traumatisme, grossesse, détresse ou récupération anormale.
- Une seule dose par l'IDE sans nouvelle autorisation médicale.
- Si récède après réponse initiale, demander un avis avant toute deuxième dose.
- Préparer aspiration, oxygène et ventilation au masque si disponibles.

Intervention IDE

- BUCCOLAM buccal : 6 mois– < 1 an 2,5 mg ; 1– < 5 ans 5 mg ; 5– < 10 ans 7,5 mg.
- À partir de 10 ans et adulte : 10 mg.
- Placer lentement la solution entre gencive et joue ; répartir des deux côtés si nécessaire.
- Si la crise persiste 10 min après la dose : urgence médicale ; ne pas redonner sans ordre.

Surveillance et traçabilité

- Tracer début/fin de crise, description, dose, lot si possible, heure, effet et tolérance.
- Surveiller respiration, conscience, SpO2 et traumatismes.
- PLS après la crise si respiration normale ; libérer les voies aériennes.
- Remettre la seringue utilisée aux secours.

Alerte immédiate

- Appel 15 immédiat si apnée, cyanose persistante, crise continue, salves ou réveil incomplet.
- Ventiler au masque si absence de respiration normale et personnel formé.
- Avis médical après toute utilisation pour réévaluer le plan.

Mention de sécurité

Le midazolam peut provoquer sédation et dépression respiratoire. Ce protocole ne remplace pas le plan nominatif du neurologue/pédiatre ; en cas de divergence, suivre ce plan et les consignes du SAMU. Compte rendu IDE écrit, daté et signé au dossier.

Fait à :

Le : / /

Signature et cachet du médecin :